

Información Paciente

Nombre : Margarita Del Carmen Quintanilla Orden **Rut :** 5.227.120-7 **N° Archivo :** 2426168
Edad : 76a 10m 27d **Fecha Nacto:** 29/10/1947 **Sexo :** Femenino
Dirección : Baldomero Lillo 4868 **Comuna :** Pedro Aguirre C **Teléfono :** 9 1234 5678

N° Epicrisis
414784

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso :** 23/09/2024 01:28 **Días Estadía: 2**
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Egreso :** 25/09/2024 17:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 22/09/2024
FI I. Qx: 23/09/2024
FI UPC: 23/09/2024

Antecedentes Mórbidos

Ant: HTA, Depresión, DLP

Qx: no

Alergias: Nitrofurantoina

Farmacos: Sertralina 50 mg Comprimidos : 1 Comprimido cada 24 horas, Atorvastatina 20 mg Comprimidos : 0.5 Comprimidos cada 24 horas, Hidroclorotiazida 50 mg Comprimidos : 0.5 Comprimidos cada 24 horas, Atenolol 50 Mg Comprimidos : 0.5 Comprimidos cada 12 horas, Losartan Potasico 50 mg Comprimidos : 1 Comprimido cada 12 horas

Antecedentes Mórbidos

Acude a urgencia por cuadro de 5 días dolor abdominal difuso, tipo colico, asociado a náuseas, vómitos y constipación, además niega tránsito a gases. Ingres a con PA 170/61 FC 105

Se administra analgesia y solicitan estudio

Ex lab

Lactico 30 Crea 1 BUN 18 ELP 136/4.3/101 RGB 24060 Hb 13.8 PQ 500000 PCR 374

AngioTC

Aorta abdominal asociada a acentuada ateromatosis mixta, observando pérdida de la representación angiográfica en relación a su extremo distal previo a la bifurcación iliaca, hallazgo que se extiende en relación a arterias ilíacas comunes bilaterales, con repermeabilización distal por colaterales.

Arteria mesentérica superior de calibre normal, observando pérdida de la representación angiográfica en relación a su tercio distal secundario a trombo hipodenso.

Distensión difusa de asas de intestino delgado y colon ascendente observando adelgazamiento e hipo realce parietal sugerente de áreas de isquemia transmural.

Áreas hipodensas esplénicas subcapsulares, en este contexto sugerentes de áreas de infarto.

Fecha Epicrisis : 25/09/2024 17:09

Fecha Última Actualización: 25-09-2024 17:09:14

Página 2 de 3

Signos de nefritis bilateral, de probable etiología inflamatoria infecciosa. Correlacionar con antecedentes clínicos y pruebas de orina.

Diverticulosis colónica observando cambios inflamatorios en relación a divertículos sigmoideos sugerente de diverticulitis aguda, con pequeña colección hipodensa adyacente como signos de complicación.

Razón por la cual ingresa a pabellón de urgencia a las 01:30, en este se describe:

Se identifica intestino delgado desde treitz hasta valvula ileocecal de aspecto violáceo, con hipomotilidad, sin francas zonas necroticas ni evidencias de perforacion. Colon transverso y descendente de aspecto vital.

Elevacion de colon transverso y evisceracion de asas de delgado hasta exponer treitz, disección medial a treitz en raiz del mesenterio identificando arteria mesenterica superior. Trombectomia mecanica con cateter Fogarty N2, se extrae de rama principal gran trombo de aspecto subagudo, seguido de fragmento de

menor tamaño, luego multiples cateterismos sin extraer mas trombos. Se cateteriza rama cercana a arteriotomia multiples veces sin obtener trombos. Reflujo inicial minimo de ambas ramas, que se torna vigoroso tras trombectomia. Se hepariniza localmente ambas ramas mesentericas. Arteriorafia con Prolene 6/0 transversa continua. Se reestablece flujo sin evidenciar filtracion de sutura. Pulso distal presente

al finalizar reparacion. Se realiza lavado de cavidad peritoneal con 2 Lt SF caliente. Se deja laparotomizada con bolsa de bogotá.

Paciente permanece en pabellón, se describe necesidad de NAD hasta 3.5. Al examen físico, perfusión límite, livideces en EElI, laparostomizada.

A las 18:15 ingresa nuevamente a pabellón de urgencia en donde se describe:

Intestino isquemico, liquido libre serohemático,serosa congestiva a nivel de ciego y colon sigmoides.

Resección de segmento isquemico de 260cm previa ligadura de vasos del mesenterio. Se explora intestino remanente, sin perforaciones, quedando cabo proximal de 140cm y cabo distal de 30cm hasta válvula ileocecal.

Exploración de cavidad identificando moderada cantidad de bilis en lecho vesicular, con vesícula en repleción con signos de colecistitis isquemica, no se logra identificar perforación. Se deja gelita en lecho vesicular.

Se deja laparotomizada con bolsa de bogotá.

Ingresa a UPC en regular estado general, con levofed a 0.15 u/k/m y con motting grado 2

Se reanima pero pese a esto evoluciona con lactato al alza y mayor moteado , se define inicio de hemofiltracion de alto volumen con mala respuesta , en examenes AM se evidencia aumento de lactato y multiples disfunciones , valorada por Cx encuentra mayor isquemia intestinal por lo que se define no nueva cirugía .

A las 1510 hrs completa 24 hrs de hemofiltracion tras lo cual comienza con multiples arritmias falleciendo a las 1550 hrs en compañía de su familia

DIAGNÓSTICOS :

1. Shock séptico foco abdominal

a) Isquemia mesentérica aguda

- Embolectomía A. mesentérica superior 23/09 (1er tiempo) + Resección intestinal extensa (260 cm aprox l. delgado, 2do tiempo) + Bolsa bogotá

b) Diverticulitis aguda complicada

- Colección pericolónica (sigmoides)

c) Falla multiorgánica 2°, en evolución

- Injuria renal aguda AKI KDIGO III

Hiperkalemia severa + Acidosis metabólica

- Hepatitis isquémica

- Coagulopatía 2°

d) VMI 23/09 a la fecha

2. Sospecha lluvia embólica

a) Infartos esplénicos + Colecistitis isquémica + Isquemia mesentérica

3. Antecedentes: HTA, DLP, Depresión

Diagnóstico de Egreso

Isquemia mesentérica - hta

Fecha Epicrisis : 25/09/2024 17:09

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:32

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Condición de Egreso Fallecido

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

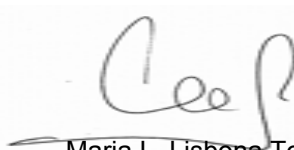
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Maria L. Lisbona Torres
Médico Tratante (Staff)